

Region:	Saksbehandler:	E-post:	Telefon:	Vår dato:	Vår referanse:
REK nord	Susanne Ramstad	rek-nord@asp.uit.no	77660388	21.06.2023	553383

Anne Mette Rustaden

Prosjektsøknad: Digital hjemmebasert styrketrening versus styrketrening med fysisk oppmøte for kreftpasienter - en 12 ukers RCT

Søknadsnummer: 553383

Forskningsansvarlig institusjon: Høgskolen i Innlandet

Samarbeidende forskningsansvarlige institusjoner: Sykehuset Innlandet HF

Prosjektsøknad godkjennes

Søkers beskrivelse

Styrketrening er vist å kunne bedre flere viktige helsevariabler etter gjennomgått kreftsykdom og behandling, men andelen pasienter som trener styrke på regelmessig basis er lav. Typiske barrierer for treningen er lang reisevei til treningslokaler og trening på ugunstige tidspunkter på døgnet. Det er derfor behov for alternative tilnærminger innen kreftrehabilitering som gagner pasienter over hele landet. «Aktiv mot kreft» har etablert «Pusterom» på flere norske sykehus hvor kreftrelatert trening tilbys, og under Covid-19 pandemien ble det digitale hjemmebaserte tilbudet «Pusterommet live» etablert. Formålet med dette prosjektet er derfor å undersøke om 12 uker (2 g/uken) med digital hjemmebasert styrketrening kan gi økt tilslutning til trening, sammenlignet med trening med fysisk oppmøte blant kreftpasienter som nylig har avsluttet sin behandling. Prosjektet vil også undersøke effekten av de to ulike treningsformene på ulike fysiske, mentale og metabolske helsevariabler.

Vi viser til søknad for ovennevnte forskningsprosjekt. Søknaden ble behandlet av Regional komité for medisinsk og helsefaglig forskningsetikk (REK) i møtet 08.06.23. Vurderingen er gjort med hjemmel i helseforskningsloven § 10.

REKs vurdering

Formålet med dette prosjektet er å undersøke om 12 uker (2 g/uken) med digital hjemmebasert styrketrening kan gi økt tilslutning til trening, sammenlignet med trening med fysisk oppmøte blant kreftpasienter som nylig har avsluttet sin behandling. Man ønsker også å undersøke effekten av de to ulike treningsformene på ulike fysiske, mentale og metabolske helsevariabler.

Prosjektet skal gjennomføres som en klinisk intervensjonsstudie. Det skal rekrutteres 120 voksne kreftpasienter som nylig har avsluttet sykehusbasert kreftbehandling.

Det skal gjennomføres funksjonelle, mentale og metabolske tester (pretester over tre test-dager), før deltakerne blir randomisert til én av to grupper; digital styrketrening hjemme, eller styrketrening med fysisk oppmøte. Etter endt intervensjonsperiode, gjennomføres samme testprosedyre på nytt (post-tester). Treningsdeltakerne skal trene 2 ganger pr uke i

12 uker. Deltakerne må bo innenfor 15 kilometer fra sykehuset.

Innsamling av data:

Det skal samles inn data fra følgende kilder/målinger:

- Kliniske undersøkelser : Måling av helsevariabler (glukosetoleranse, helsevariabler i blod), blodtrykk, ultralyd, midjemål, intermuskulært fett (MRI), måling av kroppssammensetning (DEXA scan).
- Måling av fysisk prestasjonsevne (maksimal og utholdende muskelstyrke) og funksjonell helse (six minutes step test, sit-to-stand test).
- Treningsdagbøker som beskriver tilslutning til trening, og evt. avvik fra den tiltenkte treningsprotokollen.
- Spørreskjema (Chalder`s Fatigue Questionnaire, PHQ9 questionnaire, SF-36, EORTC QLQ-C30.)

Rekruttering og kostnader :

Pasienten mottar informasjon og informasjonsskriv fra lege på 3 mnd. kontroll. Det planlegges også at legen samtidig ber om tillatelse til at prosjektledelsen tar kontakt pr. telefon for å informere videre om studien.

REK aksepterer ikke en slik løsning. Deltaker må selv kunne ta kontakt med prosjektet for ytterligere informasjon dersom man ønsker det.

Av søknaden fremgår det at deltakerne selv skal finansiere eventuelle reisekostnader for å delta i studien.

Det er et forskningsetisk prinsipp at forskningsdeltakere ikke skal ha utgifter for å være med i forskning. Deltakernes kostnader må dekkes av prosjektet.

Oppbevaring av data:

I informasjonsskrivet opplyses det at det biologiske materialet skal oppbevares i en prosjektspesifikk biobank, mens det i søknadsskjema opplyses at blodprøver skal lagres kodet i den generelle biobanken «Trainome» (REK-id: 2013/2041), situert ved HINN/SL.»

Dersom man ønsker at materialet skal inkluderes i en generell biobank må man bruke det samtykkeskjemaet som er godkjent for denne biobanken for videre oppbevaring. Det må være frivillig å avgi materiale til den generelle forskningsbiobanken. For de deltakerne som ikke samtykker til dette skal materialet slettes senest ved prosjektslutt.

Forespørsel/informasjonsskriv/samtykkeerklæring:

Samtykkeskrivet vurderes som dekkende.

Vedtak

REK godkjenner prosjektet med hjemmel i helseforskningsloven § 10, med forutsetning om at ovenstående rettelser gjøres før studien igangsettes.

Prosjektet er godkjent frem til omsøkt sluttdato 31.12.2027.

Sluttmelding

Prosjektleder skal sende sluttmelding til REK på eget skjema via REK-portalen senest 6 måneder etter sluttdato 31.12.2027, jf. helseforskningsloven § 12. Dersom prosjektet ikke starter opp eller gjennomføres meldes dette også via skjemaet for sluttmelding.

Søknad om endring

Dersom man ønsker å foreta vesentlige endringer i formål, metode, tidsløp eller organisering må prosjektleder sende søknad om endring via portalen på eget skjema til REK, jf. helseforskningsloven § 11.

Klageadgang

Du kan klage på REKs vedtak, jf. forvaltningsloven § 28 flg. Klagen sendes på eget skjema via REK portalen. Klagefristen er tre uker fra du mottar dette brevet. Dersom REK opprettholder vedtaket, sender REK klagen videre til Den nasjonale forskningsetiske komité for medisin og helsefag (NEM) for endelig vurdering, jf. forskningsetikkloven § 10 og helseforskningsloven § 10.

Med vennlig hilsen

May Britt Rossvoll
komitesekretær REK nord

Susanne Ramstad
seniorrådgiver REK nord

Kopi til:
Høgskolen i Innlandet
Sykehuset Innlandet HF
Stian Ellefsen, Anna Solheim